

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

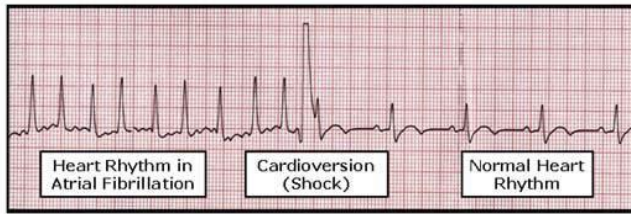
Consent Information – Patient's Copy Cardioversion

معلومات الإقرار – نسخة المريض تقويم نظم القلب

1. What is a cardioversion?

Electrical cardioversion is a procedure used to convert an abnormal heart rhythm (such as Atrial Fibrillation AF) to a normal rhythm (sinus rhythm). This is where an electrical shock is given over the chest. This electrical shock stops the abnormal rhythm of the heart for a brief moment and allows the normal heart rhythm to take over. Warfarin is usually given for at least 4 weeks prior to the cardioversion to minimize the risk of stroke that can occur during or shortly after cardioversion. Warfarin is continued for 4 to 6 weeks after a successful cardioversion. Most patients who undergo successful cardioversion are placed on oral medications to prevent recurrences of AF.

You will have the following procedure:
A needle with a tube connected to it will be put in your arm. This is called an intravenous line or IV. You will get a drug to make you sleep for a short time. While you are asleep, the doctor will use a special machine (defibrillator) that delivers specific amounts of energy to your heart muscle through patches that will be placed on your chest. This will usually restore your normal heart rhythm. Although this procedure only takes a few minutes, several attempts may be needed. Electrical cardioversion is more effective than medications alone in stopping AF and restoring a normal heart rhythm.

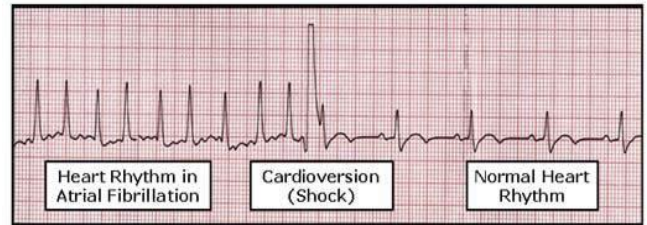


1. ما هو تقويم نظم القلب؟

تقويم نظم القلب الكهربائي هو إجراء يستخدم لتحويل إيقاع القلب غير الطبيعي (مثل الرجفان الأذيني) لإيقاع طبيعي (النظم الجيبي). ويتم ذلك بإعطاء صدمة كهربائية فوق الصدر. هذه الصدمة توقف الإيقاع غير الطبيعي للقلب لوهلة قصيرة وتتيح فرصة لعودة إيقاع ضربات القلب الطبيعي. يعطى عقار الوارفارين عادة لفترة أربع أسابيع تسبق تقويم نظم القلب لتقليل خطر السكتة الدماغية التي قد تحدث أثناء أو بعد زمن قصير من تقويم نظم القلب. يستمر إعطاء الوارفارين لفترة زمنية تتراوح من 4-6 أسابيع بعد نجاح تقويم نظم القلب. معظم المرضى الذين خضعوا بنجاح لتقويم نظم القلب يستمرون في تناول أدوية عن طريق الفم لتقادي حدوث الرجفان الأذيني مرة أخرى.

سوف تخضع للإجراء التالي:

توضع إبرة متصلة بأنبوب في ذراعك وتسمى بالخط الوريدي. سوف تعطى عقاراً ليجعلك تنام لفترة وجيزة. بينما أنت نائم، سوف يستخدم الطبيب جهاز مخصص (جهاز إزالة الرجفان) والذي يعطي كمية محددة من الطاقة لعضلة القلب من خلال رقعة (لواصق) مثبتة على صدرك. يؤدي هذا غالباً إلى استعادة إيقاع قلبك الطبيعي. وبالرغم من أن هذا الإجراء يستغرق بضع دقائق فقط، إلا أنه قد تكون هناك حاجة للقيام به أكثر من مرة. يعتبر تقويم نظم القلب الكهربائي أكثر جدوى من استخدام الأدوية فقط لإيقاف الرجفان الأذيني ولاستعادة الإيقاع الطبيعي للقلب.



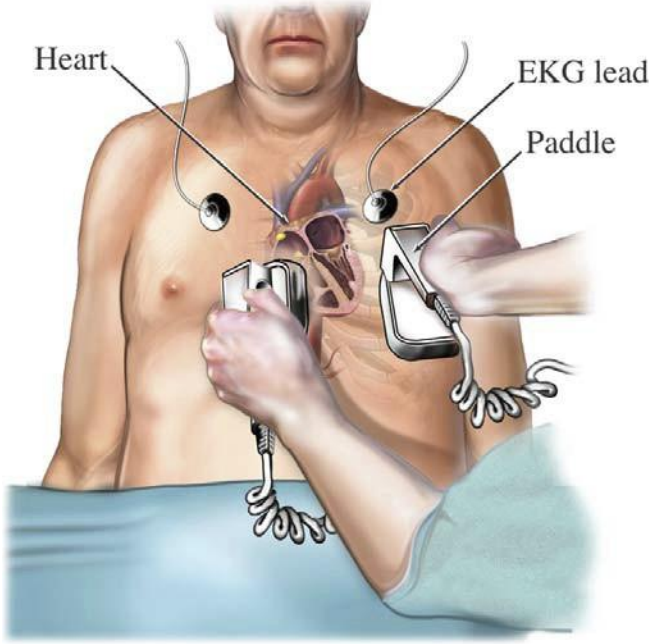


المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____



Medical Illustration @ 2008 Nucleus Medical Art.
All rights reserve www.nucleusinc.com

2. My anaesthetic

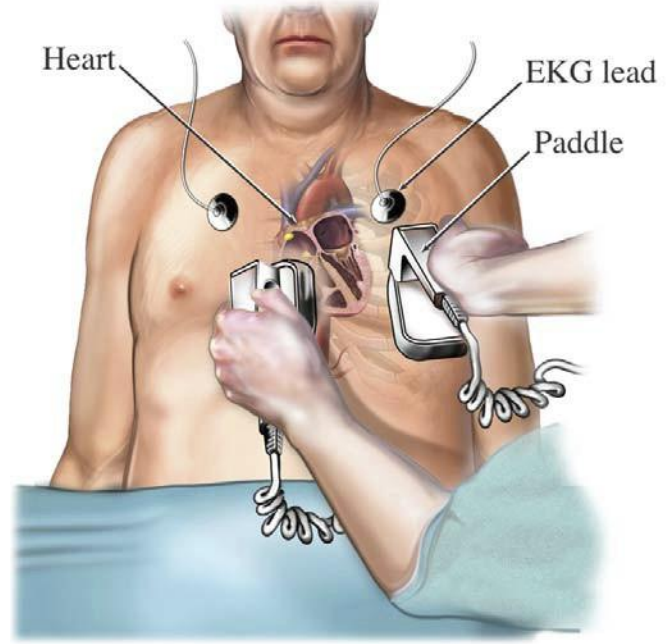
This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

In recommending this procedure your doctor has balanced the benefits and risks of the procedure against the benefits and risks of not proceeding. Your doctor believes there is a net benefit to you going ahead. This is a very complicated assessment. There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:



2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير الموضعي والأدوية المسكنة المتعلقة بالإجراء
الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر
المرتتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك
المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لقد أوصى طبيبك بهذا الإجراء بعد قيامه بمقارنة وموازنة فوائد
ومخاطر القيام بالإجراء مقابل فوائد ومخاطر عدم القيام به ،
ويرى طبيبك أنك تحصل على فائدة أكثر بخضوعك لهذا الإجراء.
إن تقدير هذا الأمر معقد جداً ، فهناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة
بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Common risks and complications (more than 5%) include:

- Skin irritation/redness from adhesive pads.
- Recurrence of Atrial Fibrillation (AF) within 12-24 months.
- The procedure may not be successful. Abnormal heart rhythm may persist.

Rare risks and complications (less than 1%) include:

- May require a Pacemaker. This is usually due to an underlying heart condition.
- Blood clot in the lung.
- Heart Attack.
- A stroke. This can cause long term disability.
- Death as a result of this procedure is rare.

Notes to talk to my doctor about:

- مخاطر ومضاعفات شائعة (أكثر من 5%) وتشمل:
- تهيج واحمرار في الجلد بسبب الرقع اللاصقة.
- حدوث الرجفان الأذيني مرة أخرى خلال 12-24 شهر.
- قد لا ينجح الإجراء ويستمر إيقاع القلب غير الطبيعي.

أخطار ومضاعفات غير شائعة (أقل من 1%) وتشمل:

- قد تظهر الحاجة لاستخدام منظم لضربات القلب . غالباً ما يكون ذلك بسبب وجود مرض كامن في القلب.
- خثرة دموية في الرئة.
- أزمة قلبية.
- سكتة دماغية قد تسبب إعاقة لفترة زمنية طويلة.
- من النادر حدوث الوفاة كنتيجة لهذا الإجراء.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
